



Hotelaria Hospitalar

Fundamentos da Hotelaria Hospitalar



Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

JULIANA APARECIDA PEREIRA MEDEIROS



AUTORIA

Juliana Aparecida Pereira Medeiros

Olá. Sou graduada em Serviço Social (ULBRA) e especialista em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente (ENSP/FIOCRUZ). Possuo experiência técnico profissional na área hospitalar em serviço social hospitalar, Hotelaria Hospitalar e segurança do paciente. Estou aqui para contribuir no desenvolvimento da cultura da qualidade e da segurança em saúde, auxiliando profissionais e organizações a melhorarem continuamente. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



OBJETIVO:

para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:

quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:

algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:

textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:

se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;



ATIVIDADES:

quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:

houver necessidade de apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:

as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?

curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:

se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;



RESUMINDO:

quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:

quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Introdução ao Estudo da Hotelaria Hospitalar	12
A Hotelaria Hospitalar como Ferramenta de Competitividade	12
Os Clientes dos Serviços Hospitalares	14
A Gestão da Hotelaria Hospitalar	16
Conceitos e Diretrizes em Hotelaria Hospitalar	20
Estrutura Física e Humanização	22
Relacionando a Bioética à Hotelaria Hospitalar	24
Privacidade e Confidencialidade	28
A Bioética Hospitalar	30
A Política Nacional de Humanização (PNH)	35
Humanização Hospitalar	35
Do Programa à Política Nacional de Humanização	37
Aplicando as Diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH)	43
Ambiência	43
Acolhimento	45

UNIDADE

01

INTRODUÇÃO

As atuais discussões sobre Hotelaria demonstram a necessidade de implementação de seu conceito nas organizações hospitalares como uma estratégia de melhoria da atenção e do cuidado aos pacientes. Planejada e executada de forma efetiva, a Hotelaria Hospitalar é sentida pelos clientes uma vez que destrói o conceito tradicional de hospital como um espaço hostil e insalubre e o caracteriza como um ambiente de produção de saúde, onde os pacientes se recuperam em condições seguras e confortáveis. Essas melhorias alcançam os usuários, acompanhantes, visitantes e a equipe de saúde em si. Por esse motivo, é fundamental o fortalecimento da Hotelaria Hospitalar e a sua profissionalização, que, ao longo dos anos, incluiu na equipe de saúde hospitalar profissionais da área de economia doméstica, turismo, nutrição, gastronomia, dentre outros, proporcionando satisfação e incluindo a hospitalidade propriamente dita. Convidamos você a desenvolver conosco os seus conhecimentos sobre a hotelaria hospitalar, colocando em prática as ações necessárias à criação de um ambiente favorável à recuperação da saúde. Interessou-se? Ao longo desta disciplina, vamos mergulhar juntos nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1 – Fundamentos da Hotelaria Hospitalar. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender o conceito de Hotelaria Hospitalar, com um olhar sobre a analogia entre um hospital e um hotel.
2. Entender a Hotelaria Hospitalar como diferencial competitivo e definir novos conceitos e terminologias técnicas sobre essa área de conhecimento.
3. Relacionar a Hotelaria Hospitalar à Bioética e à Política Nacional de Humanização (PNH).
4. Aplicar os conceitos de acolhimento e ambiência presentes na Política Nacional de Humanização (PNH).

E então, preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Introdução ao Estudo da Hotelaria Hospitalar



OBJETIVO:

Neste capítulo, você compreenderá como a Hotelaria Hospitalar pode ser um objeto de competitividade. Ainda, você saberá quais os clientes dos serviços hospitalares e como se dá a gestão da Hotelaria Hospitalar. Pronto? Vamos lá!

Cada vez mais, a Hotelaria Hospitalar se fortalece. Seu desenvolvimento justifica-se não somente por meio da sua caracterização como um componente básico da infraestrutura dos hospitais, mas também pela criação e oferta de serviços de qualidade aos seus hóspedes, gerando satisfação e segurança.

Esses atributos comuns ao turismo são foco de interesse dos clientes e das organizações hospitalares em um cenário altamente competitivo que demanda um novo perfilamento por parte das organizações hospitalares.

Atualmente, seus clientes anseiam por um valor além de serviços médicos de qualidade, agregando as suas exigências bem-estar, segurança, conforto e hospitalidade. Para o marketing, a globalização trouxe mudanças sensíveis nos comportamentos e valores dos clientes, gerando um fator crítico que alterou os critérios de exigência, incluindo a qualidade (BOEGER, 2005).

A Hotelaria Hospitalar como Ferramenta de Competitividade

A hospitalidade possui como significado o ato de "hospedar, é a qualidade do hospedeiro ou, ainda, bom acolhimento, liberalidade, amabilidade e afabilidade no modo de receber os outros". (BOEGER, 2003, p. 54)

A hospitalidade é entendida ainda como o ato humano de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas que se encontram fora de sua residência (BOEGER, 2005).

**IMPORTANTE:**

Os hospitais são complexas instituições de saúde devido à coexistência de diversos processos administrativos e assistenciais, gerando inúmeras linhas de produção simultâneas e fragmentadas dos processos executados em prol, direta ou indiretamente, dos pacientes.

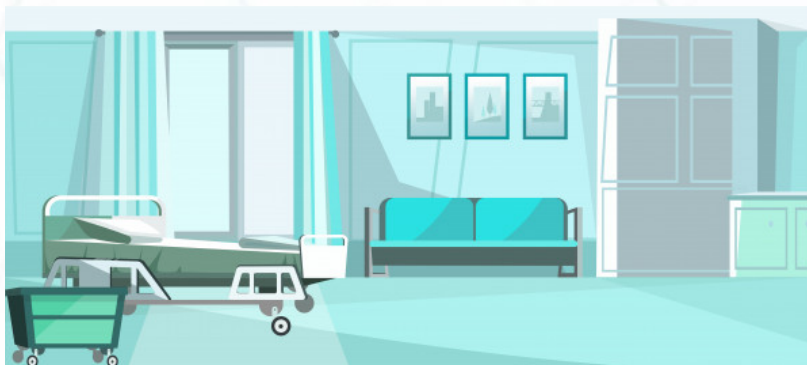
Esse fator agregado à presença de uma equipe multiprofissional com distintos graus de autonomia e alta tecnologia incorporada, ao mesmo tempo modernizando e onerando a organização, fazem com que a gestão hospitalar se preocupe cada vez mais com a Hoteleria Hospitalar como um diferencial competitivo no setor de saúde.

**NOTA:**

A modernização da assistência evoluiu concomitantemente à necessidade de valorização do paciente, hoje denominado cliente ou usuário pela sua caracterização como consumidor do serviço hospitalar.

A demanda hospitalar gerada não somente por pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), mas por clientes particulares ou provenientes de planos de saúde diversos, trouxe a necessidade de incorporação de procedimentos e processos que diferenciem a organização da concorrência pelo padrão de qualidade dos serviços prestados (CHAVES et al., 2015).

Figura 1 – A Hoteleria Hospitalar agrega segurança, conforto e qualidade aos serviços hospitalares



Fonte: Freepik.

**NOTA:**

Os serviços que compõem a Hotelaria Hospitalar tornam o ambiente favorável à recuperação dos pacientes.

Os Clientes dos Serviços Hospitalares

Dio, Rettondini e Sousa (2005 apud CAVALCANTE; SANTOS, 2016) entendem por clientes aqueles que anteriormente eram designados pelo termo paciente. Todo indivíduo em tratamento de saúde se torna cliente de saúde. Desse modo, como clientes de saúde, eles sentem-se competentes para avaliar a qualidade da atenção que recebem e optar pelo local onde serão tratados com base nessa avaliação.

**NOTA:**

Nesse contexto, os gestores hospitalares buscam implantar ferramentas anteriormente praticadas apenas em hotéis para que assim possam melhorar seus serviços e ofertar maior qualidade, tornando o ambiente hospitalar mais agradável e confortável para a recuperação da saúde.

Desse modo, alinham-se as preocupações dos hospitais às dos hotéis no que tange à qualidade dos serviços prestados, atendimento,

acomodações, tanto para os pacientes quanto para os acompanhantes, sendo por isso a utilização do termo “Hotelaria Hospitalar” (CAVALCANTE; SANTOS, 2016).

**REFLITA:**

A Hotelaria Hospitalar quebra o pensamento tradicional de um hospital como um espaço hostil, triste, com comida pouco atrativa e sem sabor, dentre outros aspectos negativos. (CAVALCANTE; SANTOS, 2016, p. 408)

Essa nova tendência dos hospitais de investirem na Hotelaria Hospitalar, introduzindo técnicas, procedimentos e serviços visando segurança, qualidade e conforto, traz como consequência um grande benefício social, físico, psicológico e emocional tanto para pacientes quanto para seus familiares visitantes e para os funcionários da instituição.

Figura 2 – A Hotelaria Hospitalar visa a transformar os hospitais em ambientes mais confortáveis e propícios à recuperação da saúde



Fonte: Pixabay

**NOTA:**

Godoi (2004) explica que a hospitalidade minimiza o sofrimento dos pacientes e de seus familiares nos momentos de dor e de fragilidade quando ela é investida como uma ferramenta de humanização, contrastando com a tradicional frieza do ambiente hospitalar.

Com esse objetivo, buscando a oferta de um serviço diferenciado nos hospitais, implanta-se Hotelaria Hospitalar, agregando ao cuidado que deve ser prestado ao paciente uma grande parcela de qualidade. Cada vez mais os clientes aumentam suas exigências e se conscientizam sobre os seus direitos enquanto consumidores.

A relação entre os hospitais e os seus clientes configura relação de consumo, logo, além de legislações próprias, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990).

A Gestão da Hotelaria Hospitalar

A gestão da Hotelaria Hospitalar tem se mostrado uma ferramenta eficiente para os hospitais que se interessam em melhorar a qualidade dos serviços prestados, além de contribuir na busca da eficiência administrativa por meio da racionalidade.

**NOTA:**

A implementação da Hotelaria Hospitalar a serviço da qualidade e eficiência torna-se peça importante na produção da saúde nas organizações hospitalares.

Sua implementação apresenta-se como uma nova perspectiva de gestão de serviços, recursos humanos e insumos hospitalares, permitindo uma reorganização dos processos internos no sentido da racionalidade e adequação da utilização de recursos, em aspectos técnico-gerenciais.

**IMPORTANTE:**

Os serviços que se incluem na Hotelaria Hospitalar estão diretamente voltados para o conforto, a segurança e o bem-estar dos clientes, alterando a percepção do ambiente para torná-lo mais acolhedor.

A estrutura de um hospital que conta com serviços de Hotelaria pode variar, principalmente pelo fato de essa ainda não ser uma atividade recorrente entre as organizações de saúde. Geralmente, a estrutura básica de um serviço de Hotelaria Hospitalar conta com leitos hospitalares compostos por móveis e equipamentos, englobando, dentre outros aspectos e serviços, (CHAVES et al., 2015):

- Lavanderia.
- Camareiras.
- Rouparia.
- Higiene.
- Limpeza.
- Gerenciamento de resíduos.
- Serviços de nutrição e dietética.
- Lanchonetes e restaurantes.
- Paisagismo.
- Segurança.
- Áreas de lazer.

**REFLITA:**

Dessa maneira, o hospital deixa de ser um ambiente frio e impessoal e torna-se mais acolhedor e confortável.

Todos esses serviços buscam proporcionar uma melhor e mais agradável estadia ao paciente, uma vez que ele se encontra em um ambiente onde não gostaria de estar, no intuito de tratar algum problema de saúde.



EXPLICANDO MELHOR:

O serviço de Hotelaria Hospitalar complementou e substituiu o serviço chamado de Governança Hospitalar.

Assim, é fundamental que se observem alguns cuidados para maximizar o ser conforto.

Figura 3 – A Hotelaria Hospitalar envolve o serviço de higienização e limpeza



Fonte: Freepik.

Dentre os serviços básicos da Hotelaria Hospitalar, destacamos aqueles relacionados à:

- Serviço de Processamento de Roupas (SPR).
- Serviço de Limpeza e Higienização (SLH).
- Serviço de Nutrição e Dietética (SND).

Estudos demonstram que, em muitos hospitais, os desafios da Hotelaria Hospitalar estão relacionados a problemas no gerenciamento dos leitos hospitalares. Assim, orienta-se que, na busca da melhoria do resultado desse processo, os serviços hospitalares estejam devidamente integrados, em plena comunicação, contribuindo com a eficiência e a produtividade de toda a organização (CHAVES et al., 2015).

EXEMPLO:

Um exemplo é a importante comunicação entre as equipes de limpeza e recepção: ao término da liberação e higienização de um quarto, a recepção já estará ciente da disponibilidade para um novo internamento naquele leito.



RESUMINDO:

E então, compreendeu tudo que estudamos neste capítulo? Vamos, então, revisar um pouco do que vimos. Você estudou que a hospitalidade é entendida como o ato humano de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas que se encontram fora de sua residência e que os serviços que compõem a Hotelaria Hospitalar tornam o ambiente favorável à recuperação dos pacientes. Em seguida, estudamos que os clientes são aqueles que anteriormente eram designados pelo termo "paciente". Todo indivíduo em tratamento de saúde torna-se cliente de saúde, e que a hospitalidade minimiza o sofrimento dos pacientes e seus familiares nos momentos de dor e de fragilidade quando investem na hospitalidade como uma ferramenta de humanização contrastando com a tradicional frieza do ambiente hospitalar. Por fim, estudamos a gestão da Hotelaria Hospitalar, que é uma ferramenta eficiente para os hospitais que se interessam em melhorar a qualidade dos serviços prestados além de contribuir na busca da eficiência administrativa por meio da racionalidade. Vimos, também, que a estrutura de um hospital que conta com serviços de Hotelaria pode variar, principalmente pelo fato de esta ainda não ser uma atividade recorrente entre as organizações de Saúde, e que ela possui como aspectos e serviços: lavanderia, camareiras, limpeza, higiene, entre outros.

Conceitos e Diretrizes em Hotelaria Hospitalar



OBJETIVO:

Neste capítulo, você entenderá os conceitos e as diretrizes relacionadas à Hotelaria Hospitalar e compreenderá a estrutura física e a humanização, bem como o relacionamento entre a Bioética e a Hotelaria, componentes importantes nessa área de trabalho. Vamos seguir juntos? Então, vamos lá!

O hospital que investe no conforto de suas instalações, na sua infraestrutura, em serviços e treinamentos de recursos humanos está humanizando o seu atendimento, priorizando o seu cliente, a sua recuperação e a sua saúde.

De acordo com Amorim (2005, p. 6):



DEFINIÇÃO:

"A Hotelaria Hospitalar é um conjunto de processos, serviços e procedimentos que visa a aumentar o conforto do paciente e de seus familiares, desde a arquitetura, as instalações, os equipamentos, até os recursos humanos".

A gestão hospitalar precisa atentar-se para o fato de que o seu cliente não é apenas o enfermo, mas também os seus familiares, funcionários, profissionais de saúde, as suas operadoras de planos de saúde, o SUS e a comunidade de forma geral.

Watanabe (2008) explica que a Hotelaria Hospitalar privilegia a satisfação de todas as necessidades do cliente, como a integridade física, a privacidade e a individualidade, respeitando os valores éticos e culturais com o máximo de confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal.



EXPLICANDO MELHOR:

A Hotelaria Hospitalar, desse modo, representa uma tendência para destituir os hospitais da fama de ambientes desagradáveis, alterando a sua essência com a inclusão de conforto e qualidade por meio dos serviços hoteleiros nas suas dependências. Desse modo, associando serviços de apoio aos serviços básicos dos hospitais, pode-se contribuir para recuperação do cliente de maneira mais rápida e efetiva.

Muito além da oferta de conforto e bem-estar dos clientes, a Hotelaria Hospitalar agrega segurança na assistência, uma vez que reestrutura e amplia os processos institucionais. Todos os processos realizados pelos serviços que compõem a Hotelaria Hospitalar respeitam normas e regras preconizadas pela legislação sanitária vigente.



IMPORTANTE:

O aumento da competitividade no setor da saúde faz com que os hospitais utilizem a Hotelaria Hospitalar como um diferencial capaz de auxiliar na formação de opinião positiva dos clientes em relação à qualidade e segurança dos serviços ofertados pela instituição, maximizando as probabilidades de sua fidelização.

Espera-se que, por meio dos serviços de Hotelaria Hospitalar realizados de forma eficiente, haja a minimização do estranhamento do paciente e de sua família quando no ambiente hospitalar. Esse fator, agregado às questões de solidariedade e humanização, acaba minimizando o sofrimento e o desconforto de todos.

Esse cliente deseja, ao receber assistência hospitalar, ser considerado único e o que lhe for ofertado permita que o período em que permanecer hospitalizado seja vivenciado com o menor sofrimento possível. Desse modo, rompe-se o tabu característico do antigo modelo de cuidado hospitalar (DIAS, 2006).

Nesse sentido, o surgimento da Hotelaria Hospitalar relaciona-se ao aumento dos questionamentos dos clientes em relação ao objetivo restrito do hospital na cura de doenças, quebrando esse paradigma e incluindo o foco na satisfação de clientes cada vez mais críticos e exigentes, que anseiam por um cuidado hospitalar humanizado, seguro e de qualidade.

Obviamente, pelas suas características, as Hotelarias hospitalares são mais facilmente encontradas em organizações hospitalares privadas que buscam posicionamento competitivo no mercado da saúde. Entretanto organizações hospitalares públicas e filantrópicas acabaram observando os benefícios de sua implementação e passaram a adotá-la de maneira igual (ALMEIDA, 2009; RIBEIRO, 2013; CHAVES et al., 2015).

Estrutura Física e Humanização

Devemos frisar que é fundamental a humanização do atendimento para que os preceitos da Hotelaria Hospitalar possam ser implantados de maneira efetiva. O principal objetivo seria transformar as dependências hospitalares em um ambiente que suprisse as necessidades dos usuários, minimizasse o seu desconforto físico e mental, acompanhados de um cuidado personalizado e humano.



NOTA:

Não podemos deixar de destacar a importância da arquitetura hospitalar que deve atender às necessidades médico-hospitalares, mantendo conforto, privacidade e segurança aos clientes.

Existem, também, em legislação específica, diretrizes acerca das edificações e do ambiente físico dos estabelecimentos que prestam serviços relacionados à saúde, de acordo com o tipo e a complexidade dos procedimentos que oferecem, todas baseadas na RDC nº 50 (BRASIL, 2002), que dispõe sobre os projetos físicos de estabelecimentos de saúde.

Figura 4 – O ambiente físico dos hospitais deve obedecer à RDC nº 50/2002



Fonte: Pixabay.

A Anvisa, por meio da Resolução RDC nº 50, de 2002, dispõe sobre “o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde”. (BRASIL, 2002)



NOTA:

Nesse sentido, os planejadores, projetistas e avaliadores de estabelecimentos de saúde – sejam da esfera pública ou privada – deverão observar os termos desse documento.

De acordo com Ribeiro (2013), deve-se planejar o espaço físico dos hospitais pensando nos usuários e nas necessidades que os acompanham, inclusive oferecendo comunicação entre os pacientes quando possível e privacidade quando necessária.

Então, para o funcionamento efetivo dos serviços da Hotelaria Hospitalar, existe a necessidade de integração com o corpo médico-assistencial, o operacional e o administrativo, uma vez que esses necessitam de se adequar às novas demandas geradas pela sua

implementação. Logo, é necessário que todos os colaboradores da organização estejam engajados.

**NOTA:**

O hospital passa a ser visto como um hotel que comercializa serviços de saúde por meio da assistência prestada por seus profissionais, afinal estarão, assim, agregados a sua hospedagem os serviços médicos hospitalares.

Anteriormente, a qualidade dos serviços da Hotelaria Hospitalar era considerada dispensável na estrutura hospitalar tradicional. Porém observou-se que a Hotelaria trouxe para o ambiente hospitalar conforto, recreação, valor e respeito à vida e privacidade dos indivíduos.

Muitos dos conceitos aplicados na Hotelaria Hospitalar que visam ao atendimento às necessidades humanas dos indivíduos provêm da Bioética.

Relacionando a Bioética à Hotelaria Hospitalar

Para Cruz, Oliveira e Portillo (2010), o desenvolvimento da humanidade está historicamente ligado, paradoxalmente, à obtenção de conhecimento que deveria ser utilizado na melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, mas que acaba sendo transformado em poder potencialmente capaz de provocar danos irreversíveis e em escalas cada vez mais amplas.

**NOTA:**

Assim, as grandes questões Bioéticas da atualidade, analisadas à luz do avanço científico e tecnológico das ciências da saúde, não se referem às competências do ser humano, e sim as suas responsabilidades.

O artigo 8º da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2005) discorre em sua redação que a vulnerabilidade

humana deve ser sempre considerada nos estudos, na prática e nas aplicações da ciência, da medicina e das tecnologias da saúde em geral.

Indivíduos e grupos vulneráveis devem sempre ser protegidos e terem sua autonomia, liberdade e integridade respeitadas. São preceitos que devem ser conhecidos e obedecidos pelos profissionais do serviço de saúde, entre eles os da gestão hospitalar (UNESCO, 2005).



EXPLICANDO MELHOR:

Os pacientes são considerados vulneráveis, por isso necessitam de foco ético especial por parte da equipe de saúde e da organização de forma geral.

Os gestores hospitalares deparam-se com um cenário organizacional extremamente complexo, pois tem-se a interação entre atores distintos em situações difíceis e, muitas vezes, com interesses conflitantes.



REFLITA:

Equipe multidisciplinar diversificada, usuários vulneráveis, pressão do mercado da saúde – representado pelos laboratórios farmacêuticos e de tecnologia médica –, instituições em situação histórica de déficit financeiro, dentre outros agentes e recursos perfazem o ambiente de uma organização prestadora de serviços de saúde, tendo os hospitais como exemplo máximo de multiplicidade organizacional.

Ashby (1964 apud COUTO; PEDROSA, 2007) enuncia que um sistema de tamanha complexidade, como um hospital, só pode ser gerido com a utilização de um sistema igualmente complexo ou superior, por isso os sistemas de gestão hospitalar integram os serviços de Hotelaria.

Por esse viés, todas as normas, atitudes e condutas no ambiente de prestação de serviços em saúde devem ser delimitadas pelos preceitos da Ética e da Bioética. Somente assim os profissionais e usuários podem

proteger-se mutuamente e ser oferecido um serviço com segurança e de real qualidade.

Você pode questionar-se sobre a aplicação da Bioética nos serviços de Hotelaria Hospitalar, uma vez que esses podem estar relativamente distantes do contato direto com os usuários que representam a essência desses princípios. Porém, como defendem Malagón-Londoño, Morera e Laverde (2003), toda atividade humana deve ser regida pelos "seres sociais" na busca sempre do bem comum.



IMPORTANTE:

Os hospitais, por se tratarem de um conjunto de seres humanos, necessitam de uma estrutura rígida de normas regulamentadoras e comportamentos para o benefício dos usuários. Esse código é definido pela influência da gestão e em conjunto com os demais profissionais das organizações.



NOTA:

A Bioética pode ser entendida, de forma simples, como a aplicação da Ética na prática dos profissionais da saúde, seja nos âmbitos do ensino, da pesquisa e exercício profissional. Assim, o cuidado individualizado e humanizado nos hospitais é de interesse bioético.

Se formos conceituar Bioética, temos (GOZZO; LIGIERA, 2012):



DEFINIÇÃO:

A Bioética é o estudo sistemático da conduta humana aplicada às ciências da vida e da saúde, analisado a partir de valores e princípios morais atualmente vigentes. Como fragmento da Ética humana, ela é voltada para as demandas que envolvem ou interferem diretamente na vida ou na saúde humana.

O modelo bioético principialista é baseado nos princípios básicos da não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Muito utilizado como referência, é questionado quanto à aplicação prática devido à complexidade e diversidade das sociedades humanas, o que dificulta se estabelecer um padrão, visto não haver homogeneidade cultural de visões e opiniões em suas partes, levando à dominação de alguns e exclusão de outros grupos do ponto de vista econômico e moral (SCHRAMM; PALACIOS; REGO, 2008).

Na prestação de serviços de saúde, estão presentes os quatro princípios básicos principialistas, de acordo com Costa (2004, apud KOERICH; MACHADO; COSTA, 2005):

1 – Beneficência: diz respeito à obrigação moral de ajudar os outros, de fazer ou promover o bem.

2 – Não maleficência: relaciona-se ao dever de se recusar a praticar qualquer mal para os pacientes, de não ocasionar danos ou expô-los à risco.

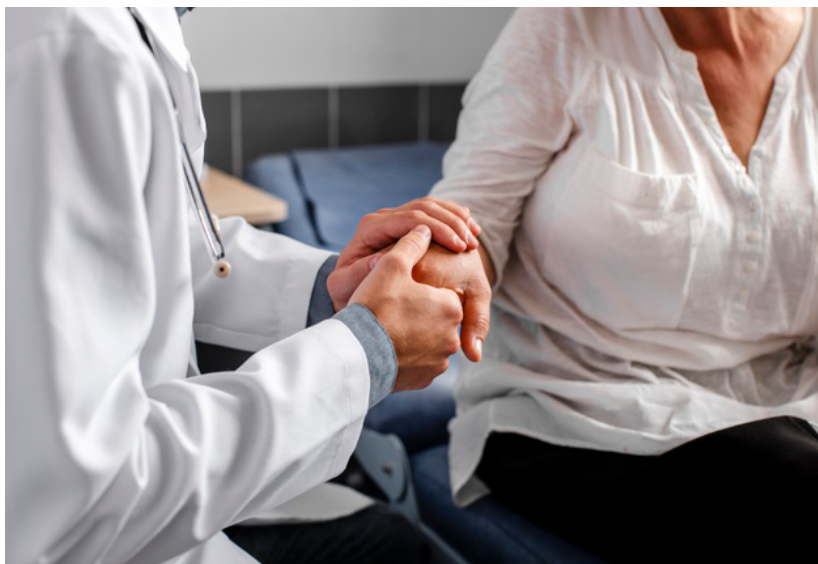
3 – Autonomia: refere-se à autodeterminação ou autogoverno, ao arbítrio de decidir sobre si próprio; resguardando a liberdade de cada ser humano.

4 – Justiça: ocupa-se da reflexão sobre a distribuição harmônica e adequada de obrigações e benefícios sociais.

**NOTA:**

Como traz Coelho, Costa e Lima (2013), o modelo bioético principialista tornou-se a teoria mais conhecida e aplicada dos últimos tempos por tratar dos conflitos morais, tecnicamente, de forma direta e coesa e proporcionar rápida assimilação dos seus princípios básicos pelos profissionais e pelas organizações de saúde, promovendo soluções rápidas no cuidado à saúde.

Figura 5 – A humanização do atendimento em saúde é preceito da Bioética principialista



Fonte: Freepik.

Privacidade e Confidencialidade

A privacidade e a confidencialidade são fundamentos primordiais da prática em saúde e importantes na delicada relação profissional-paciente. Isso por representar a indispensável confiança que deve existir na prestação de serviços em saúde devido à intimidade das informações disponibilizadas.

Segundo o Conselho Federal de Medicina (COSTA; OSELKA; GARRAFA, 1998), os preceitos, embora antigos na prática médica, continuam atuais no exercício da profissão, abarcadas no conceito de “segredo médico”.



IMPORTANTE:

Um profissional de saúde deve entender que a confidencialidade e a privacidade são pilares fundamentais da manutenção da confiança, fazendo com que os pacientes busquem ajuda profissional quando necessário, sem receios de divulgações de informações íntimas, econômicas ou sociais que possam representar constrangimentos e danos de qualquer espécie.

O direito à privacidade por parte do paciente torna-se cada vez mais significativo devido ao seu componente legal e ao contexto jurídico que casos de quebra de sigilo adquirem. Deve-se proteger a privacidade do indivíduo em todos os seus aspectos, do interpessoal aos documentos legais gerados pelos atendimentos. A violação da privacidade de dados pode afetar diretamente a vida dos indivíduos, culminando em consequências na sua vida social nos aspectos familiar, profissional, financeiro (CARVALHAL et al., 2017).



IMPORTANTE:

O ambiente físico dos hospitais e as acomodações dos pacientes, âmbito da Hotelaria Hospitalar, devem proporcionar privacidade aos pacientes.

No âmbito jurídico, o sigilo está presente no conteúdo constitucional, relacionando-se à intimidade e à privacidade, fundamentos reconhecidos no ordenamento pátrio na amplitude dos direitos humanos e nos códigos de ética profissionais.

O assunto traz à tona a necessidade de se discutir a relação profissional-paciente, as relações interpessoais dentro das instituições de

saúde, afluindo os temas da Bioética hospitalar e da humanização. A reflexão sobre a relação profissional-paciente em saúde entrelaça-se com o conceito de humanização e nos aproxima de questões ético-filosóficas que discutem as nuances do cuidado em saúde.

Nesse contexto, é importante você compreender que o foco dos serviços em saúde deve fugir do “trabalho em si” e ganhar as dimensões do indivíduo. O cuidar deve ser a reconstrução da saúde dos indivíduos, buscando a sustentação da dignidade e da vida social e familiar dos clientes desse mundo tão complexo.



IMPORTANTE:

Aqui se pode compreender a importância da Hotelaria Hospitalar na recuperação da saúde dos clientes hospitalares. Essa postura não deve, portanto, se reduzir apenas “ao tratar” e ser entendido como um atributo profissional, mas sim como atitude humanitária fundamental (CYRINO et al., 2004).

O paciente hospitalar, por exemplo, necessita de cuidados direcionados não somente aos seus problemas fisiopatológicos, mas também para uma atenção às questões psicossociais, intimamente interligadas à doença física. O medo, a ansiedade, as inseguranças e as angústias do paciente podem impactar negativamente no seu processo de recuperação.

Como você já sabe, outro aspecto importante abordado pela Bioética como parâmetro para a concretização da humanização é a relação entre os profissionais de uma equipe multidisciplinar.

A Bioética Hospitalar

O hospital é o ambiente que apresenta o modelo de cuidado mais complexo e onde se apresentam os maiores conflitos de natureza ética da área da Saúde. Os profissionais precisam estar sempre preparados para a ocorrência de situações inusitadas e que envolvam complicações clássicas da Bioética.

**NOTA:**

A sistemática hospitalar lida com crescentes níveis de pacientes, em termos de gravidade de sua patologia, o que, proporcionalmente, altera a sua estima e motivação, juntamente com profissionais e familiares.

Pontes et al. (2007) argumentam que é necessária uma reflexão pautada nos princípios éticos norteadores da conduta frente aos clientes, devido aos problemas normalmente vividos no cotidiano hospitalar e para que, de modo algum, se perca o referencial humano e social que envolve o cuidado à saúde sob pena de transformar a assistência em um serviço com sua importância real minimizada.

**IMPORTANTE:**

Para isso, não são necessários apenas recursos técnicos, provenientes do conhecimento científico, mas, sobretudo, habilidades humanas de empatia e solidariedade.

No ambiente hospitalar operacionalizado pelas equipes multidisciplinares e controlado por um gestor hospitalar, observa-se um cenário ainda de muita insegurança para todos os atores, principalmente nas instituições públicas e filantrópicas marcadas pela ingerência e a escassez de recursos. É uma situação que precariza as relações interpessoais existentes, segrega grupos corporativistas e revolta os pacientes.

**NOTA:**

O hospital é uma organização única, com deveres éticos especiais que não podem ser prejudicados quando características empresariais são introduzidas em sua cultura.

Apesar de atualmente serem entendidos e geridos como empresas – o que por um lado contribui com a eficiência administrativa e a manutenção em um cenário marcado pela insolvência da saúde pública –, o hospital não é uma organização qualquer, pois oferece um produto de valor inestimável: a vida de seus pacientes.

Figura 6 – Os hospitais são organizações extremamente complexas, onde o mercado e a ética podem entrar em conflito de interesses



Fonte: Freepik.

Pela grande variedade de profissionais que perfazem uma equipe hospitalar, pode-se entender a dimensão em que a Bioética precisa ser aplicada dentro da organização. Todos os profissionais que estão direta ou indiretamente ligados aos cuidados devem possuir conhecimento dos preceitos éticos a serem respeitados na proteção dos pacientes.

O organograma de um hospital conta com setores administrativos, operacionais e assistenciais. Pacientes deparam-se com profissionais que não estão intimamente ligados à assistência, que não possuem uma formação acadêmica específica, mas que necessitam possuir uma conduta ética padrão, ficando a cargo das instituições o desenvolvimento desse perfil, como é o caso dos colaboradores da Hotelaria Hospitalar.

Figura 7 – As heterogêneas equipes hospitalares são compostas dos profissionais de diversas funções, graus de escolaridade e de responsabilidades



Fonte: Freepik.

As equipes de higienização e manutenção, por exemplo, possuem acesso aos setores restritos do hospital, como Centros de Terapia Intensiva, Internação e Centro Cirúrgico. Assim, misturam-se à linha do cuidado e são apresentadas cotidianamente à intimidade dos pacientes.



SAIBA MAIS:

Clássico do cinema que aborda o trabalho em humanização da saúde e a dignidade humana, o filme *Patch Adams – O Amor é contagioso* é baseado na história real do médico Hunter Adams, profissional que se utiliza de métodos humanizados para tratar seus pacientes.

**RESUMINDO:**

Compreendeu tudo que estudamos neste capítulo? Esperamos que sim! Mas vamos iniciar a nossa revisão. Você deve ter estudado que a Hotelaria Hospitalar é um conjunto de processos, serviços e procedimentos que visam a aumentar o conforto do paciente e seus familiares, desde a arquitetura, as instalações, os equipamentos até os recursos humanos. Além disso, deve ter visto a importância da estrutura física na humanização visando a atender as necessidades médico-hospitalares mantendo conforto, privacidade e segurança aos clientes. Em seguida, você estudou que a Bioética pode ser entendida, de forma simples, como a aplicação da ética na prática dos profissionais da Saúde, seja nos âmbitos do ensino, da pesquisa e do exercício profissional, e que o modelo bioético principialista corrobora para a prestação de serviços de saúde. Estudamos, também, que a privacidade e a confidencialidade são primordiais da prática em Saúde e importantes na relação profissional-paciente, e que o hospital é o ambiente com o modelo de cuidado mais complexo e onde se apresentam os maiores conflitos de natureza ética da área da Saúde. E então, gostou? Prontos para estudar mais?

A Bioética, portanto, sintetiza a necessidade de humanizar a prestação de serviços de saúde, impondo parâmetros ideais de enfrentamento das injustiças e dos desrespeitos, quando observadas as relações interpessoais entre profissional-cliente e entre a organização de saúde e seus clientes. Este representa atualmente o grande desafio para as organizações prestadoras de serviços de saúde: humanizar as relações (CYRINO et al., 2004).

A Política Nacional de Humanização (PNH)



OBJETIVO:

Um importante parâmetro a ser considerado na Hotelaria Hospitalar é o respeito aos preceitos da humanização hospitalar na assistência à saúde. Assim, este capítulo será dedicado ao estudo da Política Nacional de Humanização. Pronto? Vamos em frente.

Humanização Hospitalar

O termo "humanização" aplicado ao ambiente hospitalar pode nos desencadear diferentes entendimentos.

A humanização em Saúde envolve a relação entre os profissionais e os usuários, focada na valorização dos indivíduos, por meio do fomento à conduta ética, empática e humana.

Backers et al. (2005) entendem a humanização como:

A humanização, no entender da equipe de humanização, significa, fundamentalmente, criar um clima organizacional favorável ao atendimento do paciente. É um processo que não se resume no atendimento técnico e mecânico do paciente, mas na compreensão e cuidado do paciente como um todo. Para que o paciente possa ser atendido de forma integral, a equipe necessita trabalhar de forma integrada e, para que uma equipe possa atuar de forma integrada, necessita melhorar a comunicação entre os profissionais; promover os trabalhadores, no sentido de valorizar iniciativas e compartilhar ideias, colocando ênfase na socialização das ações humanas para estabelecer um melhor convívio. (BECKERS et al., 2005, p. 223).

Uma vez que a sociedade se torna cada vez mais formal, distanciando as pessoas, a humanização surge como um projeto de oposição a essa tendência competitiva e mercantil do atual mundo globalizado. Segundo Beckers et al. (2005):

A humanização possibilita ao ser humano exercer suas potencialidades criativas, desde que as condições ambientais e profissionais sejam facilitadoras. A humanização significa conciliar o trabalho com a vida pessoal e a felicidade coletiva. Humanizar significa, ainda, ser capaz de identificar e valorizar, na prática, o que é importante e fundamental aos olhos de quem convive e estabelece as relações de trabalho no coletivo, como ter sua condição de sujeito trabalhador reconhecida (BACKERS et al. 2005, p. 226).



IMPORTANTE:

Assim, objetiva-se reiterar a necessidade, no cuidado à saúde, da solidariedade, do apoio social, proteção aos vulneráveis e contrário à violência e os maus-tratos. Para isso, é necessário melhorar a comunicação entre os diversos atores envolvidos no processo do cuidado em saúde (GOULART; CHIARI, 2010).

Figura 8 – A humanização é parâmetro de satisfação do cliente e da qualidade hospitalar



Fonte: Freepik.

Inicialmente, a expressão "humanização aplicada à saúde" era entendida como a ação de movimentos religiosos, filantrópicos e

paternalistas. Atualmente, o conceito foi ampliado para englobar a capacidade de organizações e profissionais de oferecer uma assistência de qualidade, com acolhimento, ambiência e atenção às condições de trabalho dos profissionais (SILVA; SILVEIRA, 2011).

No SUS, um dos principais gargalos para a efetivação da humanização é a forte presença do modelo de assistência na formação acadêmica e na práxis dos profissionais de saúde (que foca na doença) aliados à precariedade das condições de trabalho, ao acesso ineficiente aos serviços, à pequena participação social na gestão do sistema, refletindo, de maneira conjunta e maximizada, na criação do cenário ainda distante do idealizado no exercício cotidiano do cuidado em saúde no Brasil (COTTA, 2013).

A problemática de que trata a humanização não se restringe ao plano das relações pessoais entre terapeutas e pacientes, embora chegue até ele. Não se detém em rearranjos técnicos ou gerenciais das instituições, embora dependa deles. Trata-se de um projeto existencial de caráter político, trata-se de uma proposta para a polis (AYRES, 2005).



NOTA:

Desse modo, devido à necessidade de alteração dessa situação, instituiu-se a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde (PNH) como uma estratégia de melhoria da qualidade do cuidado e fortalecimento do SUS.

Do Programa à Política Nacional de

Humanização

Humanizar é buscar uma transformação cultural tanto nas práticas assistenciais quanto na gestão em saúde, exercendo uma conduta ética, respeitosa, acolhedora do usuário, tratando-o como um cidadão, e não apenas como um cliente de serviços de saúde (SILVA; SILVEIRA, 2011).



IMPORTANTE:

Com esse propósito, a Política Nacional de Humanização (PNH) surge no intuito de contribuir para a melhoria da qualidade da atenção e da gestão da saúde no Brasil, pautada no fortalecimento da humanização como política pública que associa o modelo de atenção ao de gestão (BRASIL, 2013).

Assim, temos como principais prioridades-alvo da Política Nacional de Humanização (PNH):

- Transversalidade, promovendo a comunicação entre as diferentes especialidades e práticas de saúde, além de estar presente e inserida em todas as políticas e programas do Sistema Único de Saúde. Assim, a PNH procura uma transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre os indivíduos, deslocando-os do isolamento e das relações estabelecidos pela hierarquia.

Figura 9 – Transversalidade



Fonte: Freepik.

- Indissociabilidade entre atenção e a gestão em saúde. As decisões que a gestão toma influenciam de forma direta na atenção à saúde. Desse modo, os trabalhadores e os usuários têm o dever de entender de que forma funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde e de participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações.
- Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Qualquer alteração na gestão e atenção constitui-se em mais concreta quando a autonomia e a vontade das pessoas envolvidas forem ampliadas. Sempre é necessário considerar que os usuários não são apenas pacientes, e que os trabalhadores não cumprem apenas ordens, e o papel de cada um deve ser reconhecido.
- Acolhimento por meio da escuta qualificada.

Figura 10 – Acolhimento



Fonte: Freepik.

- Ambiência, tornando os espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis.
- Clínica ampliada e compartilhada.

- Valorização dos trabalhadores.
- Melhoria das condições de trabalho e atendimento.
- Defesa dos direitos dos usuários.
- Respeito às questões de gênero, etnia, orientação sexual e às populações específicas.

No ano de 2003, a humanização deixou de ser um programa e tornou-se uma política nacional, na busca da efetivação do direito e dos princípios constitucionais da saúde no Brasil (BRASIL, 2004). A política foi elaborada com a finalidade de colocar em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no dia a dia dos serviços de Saúde, realizando mudanças nos modos de gerir e cuidar:

Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a PNH conta com equipes regionais de apoiadores que se articulam às secretarias estaduais e municipais de saúde. A partir desta articulação se constroem, de forma compartilhada, planos de ação para promover e disseminar inovações nos modos de fazer saúde. (BRASIL, 2003, p. 3)

**NOTA:**

Nesse contexto da humanização nos serviços de saúde, surgem importantes olhares temáticos, como o parto humanizado e a humanização da atenção hospitalar. De maneira geral, a Política Nacional de Humanização revela uma estratégia de valorização da dimensão humana no cuidado em saúde (MOREIRA et al., 2015).

Figura 11 – A Política Nacional de Humanização deve pautar o cuidado nas organizações hospitalares



Fonte: Freepik.

A inclusão dos trabalhadores é fundamental para que eles possam reinventar os seus processos de trabalho.

Além disso, existem diretrizes estabelecidas pela PNH em que estão dispostas orientações clínicas, éticas e políticas, sendo elas (BRASIL, 2003):

- Acolhimento.
- Gestão participativa e cogestão.
- Ambiência.
- Clínica ampliada e compartilhada.
- Valorização do trabalhador.
- Defesa dos direitos dos usuários.

**RESUMINDO:**

Apreendeu tudo que estudamos neste capítulo? Esperamos que sim, mas vamos revisar um pouco do que vimos. Neste capítulo, estudamos a Política Nacional de Humanização e entendemos que a humanização em saúde envolve a relação entre os profissionais e os usuários, focada na valorização dos indivíduos, por meio do fomento à conduta ética, empática e humana. Vimos, ainda, que essa política objetiva reiterar a necessidade no cuidado à saúde, na solidariedade, no apoio social, na proteção aos vulneráveis. Para isso, é necessário melhorar a comunicação entre os diversos atores envolvidos no processo do cuidado em saúde. Em seguida, estudamos que a Política Nacional de Humanização (PNH) surge com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade da atenção e da gestão da saúde no Brasil, pautado no fortalecimento da humanização como política pública que associa o modelo de atenção ao de gestão e tem como prioridades a transversalidade; a indissociabilidade entre atenção e a gestão em saúde; o protagonismo; a corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos; o acolhimento por meio da escuta qualificada; a ambiência, tornando os espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis; a clínica ampliada e compartilhada; a valorização dos trabalhadores; a melhoria das condições de trabalho e atendimento; a defesa dos direitos dos usuários; e o respeito às questões de gênero, etnia, orientação sexual e às populações específicas.

Aplicando as Diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH)



OBJETIVO:

Neste capítulo, você compreenderá os conceitos de ambiência e acolhimento no âmbito da Hotelaria Hospitalar, bem como a sua importância para a Política Nacional de Humanização. Vamos lá?

Ambiência

A PNH define ambiência como tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutive. Em interface com os demais dispositivos da PNH, esse conceito envolve questões relativas a conforto, privacidade, acolhimento, integração, espaços de "estar", assim como espaços que propiciem processo reflexivo, inclusão e participação (BRASIL, 2013).

Assim, a ambiência tem como objetivo "criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas" (BRASIL, 2003, p. 10).



VOCÊ SABIA?

Na composição da ambiência estão presentes elementos, como: forma, cor, luz, cheiro, som, texturas etc.

A ambiência deve ser feita com "a discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários e trabalhadores de cada serviço é uma orientação que pode melhorar o trabalho em saúde" (PNH, 2003, p. 10).

Considerando essa conceituação, a PNH propõe atenção à busca dos seguintes objetivos (BRASIL, 2013):

- Oferecer espaços de acesso e espera que diferenciem atendimentos preferenciais, que facilitem a priorização do atendimento e a movimentação de usuários e profissionais – diferenciação de urgências e emergências, entradas separadas para criança/gestante, priorização do atendimento a idosos, atenção especial aos grupos vulneráveis vítimas de violência e pessoas com necessidades especiais.
- Oferecer espaços de atendimento ao paciente com privacidade e conforto.
- Dispor de mobiliários confortáveis e colocados de forma a permitir a interação entre os usuários e destes com os profissionais.
- Contribuir para que os espaços sejam contíguos ou permitam integração do trabalho multiprofissional.
- Garantir fácil orientação e fluxo de deslocamento dos usuários entre as áreas e serviços.
- Favorecer o acolhimento ao visitante, oferecendo espaços de escuta, recepção e orientação.

Figura 12 – A empatia deve ser parte da conduta de profissionais da Saúde



Fonte: Freepik.

- Facilitar a participação do acompanhante ou familiar, disponibilizando conforto e acolhimento, áreas informes aos familiares, áreas de espera, convivência e descanso com assentos confortáveis e em quantidade compatível.
- Respeitar peculiaridades culturais, sociais e religiosas.
- Oferecer áreas de trabalho em grupo e espaços para reuniões interprofissionais.
- Oferecer áreas de apoio em número e condições adequadas a todos os profissionais.
- Oferecer áreas externas que favoreçam o acesso, a espera e o descanso de acompanhantes e trabalhadores.

Acolhimento

Devemos entender que a Hotelaria Hospitalar envolve desde a entrada do cliente no hospital, sua recepção, seu atendimento, a internação até a sua saída.

Figura 13 - Acolhimento



Fonte: Freepik.

**NOTA:**

Desse modo, todos os setores hospitalares estão envolvidos na qualidade da assistência ao paciente, principalmente no que tange ao respeito à humanização do atendimento.

O acolhimento precisa estar presente na instituição e deve ser realizado pelos seus colaboradores de modo a qualificar a construção do vínculo entre as partes. O acolhimento pode amenizar a condição desfavorável física e emocional do paciente e seus acompanhantes, potencializando assistência e gerando valor para os usuários (BRASIL, 2003).

De forma geral, acolher, segundo a PNH:

É reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva (BRASIL, 2003, p. 7-8).

**TESTANDO:**

Vamos, agora, discutir um caso prático:

O serviço de ouvidoria de um hospital regional vem recebendo inúmeras reclamações acerca da qualidade dos serviços prestados pela instituição. Após tratamento e análise crítica dessas percepções dos usuários, percebeu-se que a grande maioria das reclamações direcionadas à ouvidoria são relacionadas à humanização do atendimento. Buscando a resolução do problema apontado pelos clientes e elencados pelo serviço de ouvidoria, os gestores procuram por uma norma ou documento instrutivo que possa orientá-los na melhoria do cuidado à saúde na instituição.

Analisando as reclamações direcionadas à ouvidoria, a equipe gestora do hospital deparou-se com situações em que, na percepção dos usuários, houve: desrespeito à privacidade dos pacientes; falta de ambiência; comportamento antiético dos profissionais; e comunicação insatisfatória com os pacientes e familiares.

Porém, como constataram que não havia internamente nenhuma norma ou protocolo que orientasse os profissionais e demais colaboradores quanto à qualidade do cuidado relacionado aos problemas apontados, seria importante identificar a melhor referência para utilização em treinamentos setoriais.

As questões elencadas se relacionam à humanização do atendimento? O tratamento dessas reclamações pode melhorar a qualidade do cuidado à saúde ou devem ser desconsideradas? A Política Nacional de Humanização (PNH) pode orientar a equipe gestora na resolução desse problema?

Figura 13 – Humanização



Fonte: Freepik.

Pelo que estudamos, vimos que a Política Nacional de Humanização trabalha nas instituições de saúde e possui como foco principal os

conceitos de transversalidade; comunicação efetiva entre a equipe do cuidado; indissociabilidade entre atenção e gestão em saúde, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos; acolhimento por meio da escuta qualificada; ambiência, tornando os espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis; clínica ampliada e compartilhada; valorização dos trabalhadores; melhoria das condições de trabalho e atendimento; defesa dos direitos dos usuários, dentre outros aspectos que desenvolvam a valorização dos indivíduos, por meio do fomento à conduta ética, empática e humana.

A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as ações e na prestação de serviços em saúde. Acolhimento, promoção da comunicação, relações interpessoais, escuta qualificada e ambiência devem ser implantados de maneira efetiva para proporcionar uma melhor forma de cuidar e organizar o trabalho.

Desse modo, a PNH é a melhor referência para ser utilizada nos treinamentos com os funcionários por tratar dos pontos de melhoria identificados na ouvidoria e que geraram reclamações por parte dos clientes.

Observando a PNH, a equipe gestora percebeu que o hospital realmente estava desrespeitando as diretrizes da humanização, porém, baseando-se em suas orientações, pode corrigir os problemas identificados, e, em pouco tempo, a ouvidoria e as pesquisas de satisfação demonstraram grande alteração na percepção dos clientes quanto aos serviços prestados pela organização.

Essa importante dimensão das práticas em saúde – a humanização – representa hoje um importante requisito dos clientes a ser atendido pelas organizações de saúde, presente nas políticas de qualidade. Sua análise, baseada na percepção dos clientes, pode ser coletada por meio dos serviços de ouvidoria hospitalar.



RESUMINDO:

Neste capítulo, entendemos que o acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH) que não tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de saúde (BRASIL, 2013).

O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde (BRASIL, 2003).

Não devemos minimizar o conceito de acolhimento como sendo somente a recepção da demanda espontânea nas portas hospitalares. O acolhimento deve ser entendido como um encontro que prepara o cliente, cria o vínculo e abre espaço para a produção da saúde (BRASIL, 2004).

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002**. Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Brasília: Anvisa, 2002.

ALMEIDA, M. N. B. C. **Hotelaria Hospitalar**: cultura e hospitalidade no atendimento a idosos. Centro de Excelência em Turismo. Universidade de Brasília: DF, 2009.

AMORIM, L. J. **A necessidade do serviço humanizado na Hotelaria Hospitalar**. Alagoas: FAL, 2005.

BOEGER, M. A. **Gestão em Hotelaria Hospitalar**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

BOEGER, M. A. **Gestão em Hotelaria Hospitalar**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

BRASIL. **HumanizaSUS**: equipe de referência e apoio matricial. Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. **HumanizaSUS**: Política Nacional de Humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.

BRASIL. **Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm. Acesso em: 17 dez. 2019.

BRASIL. **Política Nacional de Humanização - PNH**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

CARVALHAL, G. F. et al. Recomendações para a proteção da privacidade do paciente. **Rev. Bioét.**, Brasília, v. 25, n. 1, p. 39-43, abr. 2017.

CAVALCANTE, E.D.C.; SANTOS, J. A. Hotelaria Hospitalar. **Revista Hospitalidade**, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 405-428, ago. 2016.

CHAVES, L. D. P. et al. Governança, higiene e limpeza hospitalar: espaço de gestão do enfermeiro. **Texto Contexto - Enferm.**, Florianópolis, v. 24, n. 4, p. 1166-1174, dez. 2015.

COELHO, A. F. V. C. M. B; COSTA, A. K. G; LIMA, M. G. Da ética principalista para a Bioética de intervenção: sua utilização na área da Saúde. **Revista Tempus - Actas de Saúde Coletiva**. v. 7, n. 4, 2013.

COSTA, S. I. F.; OSELKA, G.; GARrafa, V. (Coordenadores). **Iniciação à Bioética**. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.

COTTA, R. M. M. et al. Debates atuais em humanização e saúde: quem somos nós?. **Ciênc. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 171-179, jan. 2013.

COUTO, R. C., PEDROSA, T. M. G. **Hospital: acreditação e gestão em saúde**. 2. ed. Belo Horizonte: IAG Saúde, 2007.

CYRINO, A. P. et al. O projeto "Cuidando do Cuidador": a experiência de educação permanente em saúde do Centro de Saúde Escola de Botucatu. **Trab. Educ. Saúde**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 367--80, set. 2004.

GODOI, A. F. **Hotelaria Hospitalar e humanização no atendimento em hospitais: pensando e fazendo**. São Paulo: Ícone, 2004.

GOULART, B. N. G. de; CHIARI, B. M. Humanização das práticas do profissional de saúde: contribuições para reflexão. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 1, p. 255-269, jan. 2010.

SILVA, I. D. da; SILVEIRA, M. F. A. A humanização e a formação do profissional em Fisioterapia. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. 1, p. 1535-1546. 2011.

UNESCO. **Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos**. Lisboa: UNESCO, 2005.

WATANABE, S. Hotelaria Hospitalar. **Sonia Watanabe**, 2008. Disponível em: <http://soniawatanabe.sites.uol.com.br>. Acesso em: 20 fev. 2022.

